A Pessoa com TEA na Emergência e na Internação

Cartilha de orientação para a equipe hospitalar: pronto-socorro, enfermaria, exames e cirurgia

Classificação de risco · Dor · Procedimentos · Rotina · Alta



Para enfermagem, equipe médica e multiprofissional

Material educativo · Autoria: Dr. Patrício Almeida
Série “Atendimento à Pessoa com TEA”

Por que esta cartilha

O hospital reúne tudo o que mais sobrecarrega a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA): **barulho de alarmes, luzes fortes, espera imprevisível, muitas pessoas desconhecidas, toques e procedimentos invasivos** e a quebra total da rotina. Na emergência, a crise de sobrecarga pode ser confundida com agitação ou "falta de limite"; na internação, dias de rotina quebrada aumentam o sofrimento e dificultam o tratamento.

Esta cartilha traz o manejo **por momento**: a chegada e a classificação de risco, a avaliação e os procedimentos na emergência, a admissão e a rotina na enfermaria, os exames, a cirurgia e a alta. Vale para crianças e adultos, com ou sem fala.



Quem usa

Enfermagem (triagem, pronto-socorro, enfermaria, UTI, centro cirúrgico), equipe médica, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social e recepção. A página 7 ("Eu no hospital") pode ser impressa e entregue à família na admissão.

EMERGÊNCIA

Identificar o TEA na classificação de risco, sala calma, avaliar a dor de outro jeito, um procedimento por vez, diferenciar crise de sobrecarga de agitação, nunca conter de primeira.

INTERNAÇÃO

Acompanhante 24 h, mesma equipe, rotina visual do dia, quarto com menos estímulos, objetos de casa, alimentação adaptada, preparo para exames e cirurgia, alta com orientações visuais.

O que você encontra aqui

3 · Emergência: chegada, classificação de risco e espera

4 · Emergência: avaliação da dor, procedimentos e crise

5 · Internação: admissão, quarto e rotina do dia

6 · Internação: exames, cirurgia e alta

7 · História social "Eu no hospital" (para a família)

8 · Informativo, escala de dor e ficha do perfil sensorial

Regra de ouro: previsibilidade, uma coisa de cada vez e nunca forçar. No hospital, o acompanhante é parte da equipe: ele conhece os sinais, as palavras e o que acalma.

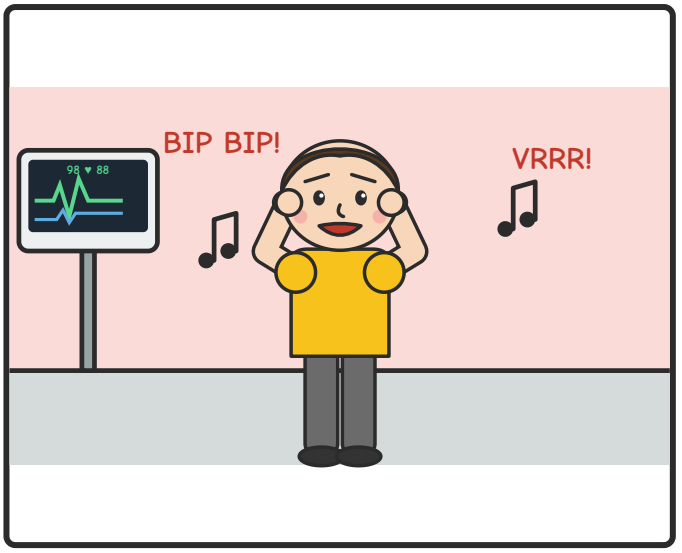
A pessoa com TEA tem direito a atendimento prioritário e a acompanhante em tempo integral (Lei 12.764/2012; Lei 13.146/2015; ECA e Estatuto do Idoso quando aplicáveis; Lei 13.977/2020, da Carteira de Identificação). Esta cartilha é educativa e não substitui os protocolos institucionais nem a avaliação clínica individual.

1 EMERGÊNCIA: a chegada

Classificação de risco, espera e primeiro contato



1. Na classificação de risco, a enfermeira pergunta sobre o TEA, registra o alerta e usa a escala de faces para a dor. A família vai para a sala calma.



2. O que leva à crise: alarmes, luz forte, gente demais, toques sem aviso e espera sem fim. Reduzir estímulos é parte do tratamento.

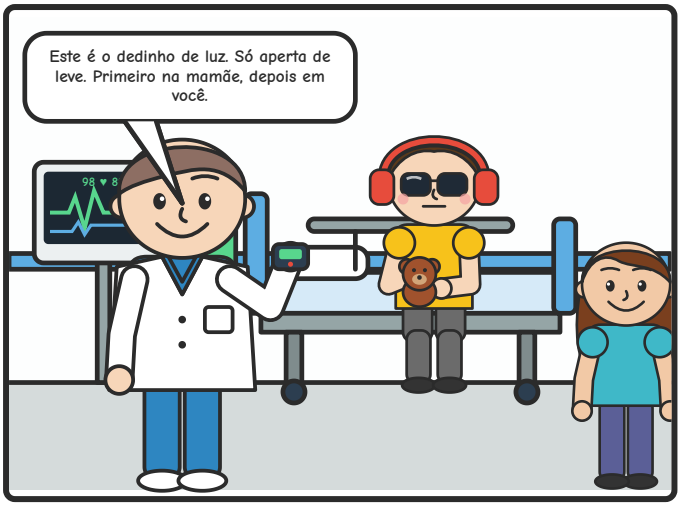
Checklist da chegada

- **Pergunte e registre:** "Tem TEA ou outra condição que mude o jeito de atender?" Marque o alerta na ficha e na pulseira; comunique a equipe antes de cada contato. A Carteira de Identificação (CIPTEA) ajuda, mas não é obrigatória.
- **Classificação de risco com atenção redobrada:** a pessoa com TEA pode **não demonstrar dor** da forma esperada ou reagir muito a um estímulo pequeno. Use a escala de faces, observe mudanças de comportamento e **ouça o acompanhante** ("ele nunca ficou assim").
- **Espera em sala calma** ou canto quieto: menos pessoas, luz suave, sem TV alta. Reduza o tempo de espera sempre que o quadro clínico permitir (prioridade legal).
- **Acompanhante o tempo todo**, inclusive em procedimentos, exames e sala de emergência, sempre que for seguro. Pergunte a ele: como comunica? o que acalma? o que piora? já fez acesso venoso?
- **Uma pessoa de referência** fala com a pessoa; os demais falam com o acompanhante. Apresente-se pelo nome, diga o que vai fazer, na altura dos olhos, sem exigir contato visual.
- **Ofereça o kit sensorial:** fones ou abafadores, óculos escuros, objeto de conforto, brinquedo ou tablet. Permita que fique com o próprio celular e os fones.
- **Combine os sinais:** mão levantada = PARE (quando não for emergência vital), polegar = tudo bem. Combine também o tempo: "conto até dez e solto".

Peça a história em uma folha: muitas famílias já têm um "passaporte" do TEA com o que funciona e o que não funciona. Fixe no prontuário e passe ao próximo plantão.

2 EMERGÊNCIA: avaliação e procedimentos

Dor, exame físico, acesso venoso, medicação e crise



3. No box, Falar–Mostrar–Fazer: oxímetro, estetoscópio, braçadeira e eletrodos primeiro no acompanhante ou no ursinho, depois na pessoa.



4. Mão levantada é PARE. Quando a situação não é de risco de vida, parar, respirar e retomar evita a crise e a contenção.

Como proceder

Exame físico em etapas e com aviso: "vou ouvir seu peito, vai ficar frio". Comece pelo que incomoda menos; mãos e pés antes do rosto e da boca. Deixe a pessoa segurar o instrumento.

Agrupe os procedimentos (coleta, acesso, medicação) em um só momento, com o profissional mais experiente, para **uma punção só**. Anestésico tópico quando houver tempo. Garrote mostrado e testado antes.

Diga o que vai sentir e por quanto tempo: "aperta um pouco, conto até dez". Evite "não vai doer" e "é rapidinho". Distração ativa: vídeo, bolha, contagem.

Reduza estímulos no box: silencie alarmes não essenciais, luz direta desligada quando possível, uma voz de cada vez, sem equipe entrando e saindo.

Crise de sobrecarga (meltdown) não é agitação psicomotora: tapar ouvidos, gritar, balançar, bater em si, tentar fugir. Ação: retire estímulos, dê espaço e tempo, acompanhante perto, fale pouco. Não negocie nem toque sem aviso.

Contenção física e sedação são o último recurso, só com indicação clínica, decisão médica, consentimento do responsável e protocolo da instituição, pelo menor tempo possível, com registro. Se o procedimento pode esperar: pare, reagende, planeje.

Encerre cada etapa com reforço: "você deixou medir a pressão, muito bem". Adesivo ou carimbo também vale para adultos que gostem.

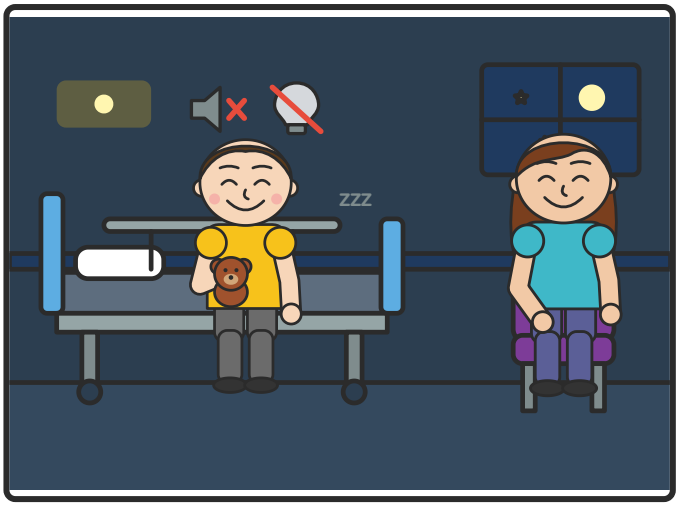
Atenção clínica: dor abdominal, fratura, otite, constipação e refluxo muitas vezes aparecem só como mudança de comportamento, autoagressão ou recusa alimentar. Investigue causa orgânica antes de atribuir a "comportamento do autismo".

3 INTERNAÇÃO: admissão e rotina

O quarto, o dia a dia e a noite



5. Na admissão, a enfermeira monta com a família o quadro visual do dia: remédio, lanche, brincar, visita, banho, dormir. Objetos de casa ficam à vista.



6. À noite: luz baixa, alarmes no mínimo, acompanhante ao lado, aferições agrupadas para não acordar a cada hora.

Checklist da internação

- **Acompanhante em tempo integral**, com cadeira ou poltrona e refeição. Revezamento combinado para não trocar de pessoa de surpresa. Ele participa dos cuidados (banho, alimentação, medicação oral).
- **Quarto:** preferir individual ou canto mais quieto, longe do posto e de equipamentos barulhentos; luz regulável; porta fechada quando possível. Evite trocar de leito.
- **Rotina visual do dia** fixada na parede (figuras ou fotos): horários de medicação, refeições, banho, visitas, fisioterapia, sono. Avise mudanças com antecedência e atualize o quadro.
- **Mesma equipe, mesma sequência:** escala fixa de técnicos sempre que possível; passagem de plantão inclui "como ele se comunica, o que acalma, o que funcionou". Apresente cada pessoa nova pelo nome.
- **Agrupe sinais vitais e medicações** nos mesmos horários, com aviso prévio; aferição no colo ou sentado; use o quadro para mostrar "agora é remédio, depois é brincar".
- **Alimentação e higiene:** seletividade alimentar é comum. Pergunte o que ele aceita (textura, cor, marca, talher) e peça à nutrição a adaptação; permita alimentos de casa quando liberado. Mantenha a rotina de escovação e banho do jeito dele.
- **Objetos e atividades:** travesseiro, cobertor, brinquedo, tablet, fones; brinquedoteca, terapia ocupacional, psicologia. Tempo de tela pode ser o regulador que evita a crise.

Prescrição sensorial: registre no prontuário as medidas combinadas (luz baixa, aferições às 8/14/20 h, acompanhante nos procedimentos). O que está prescrito a equipe cumpre, em todos os plantões.

4 INTERNAÇÃO: exames, cirurgia e alta

Preparar cada passo e sair bem



7. Antes da cirurgia: visita ao centro cirúrgico, máscara de anestesia para brincar em casa, escolha do "cheirinho", ursinho até dormir e acompanhante na indução.



8. Na alta, orientações com figuras, receita explicada ao acompanhante e retorno marcado antes de sair. Encerrar bem é prevenir a próxima crise.

Como proceder

Exames de imagem e laboratório: explique com fotos do aparelho; agende o primeiro horário; leve fones e óculos; acompanhante na sala quando a proteção radiológica permitir. Raio-X e ultrassom sentados ou no colo. Ressonância: simular o barulho antes; avaliar sedação com a anestesia só se necessário.

Pré-operatório: consulta com a anestesia conhecendo o perfil sensorial; história social da cirurgia; visita ao centro cirúrgico; jejum com horário claro no quadro; medicação pré-anestésica quando indicada; **acompanhante na indução e na sala de recuperação** sempre que o serviço permitir.

Pós-operatório e dor: avalie a dor por comportamento (escala de faces, FLACC, relato do acompanhante) e trate de forma preventiva, em horário fixo. Curativos e drenos com Falar–Mostrar–Fazer; proteja acessos e sondas de forma discreta, sem contenção.

UTI e isolamento: mantenha o acompanhante, o objeto de conforto e o quadro visual; reduza alarmes sonoros; visitas programadas das mesmas pessoas; sedação e contenção só por indicação clínica e com reavaliação diária.

Alta: orientações por escrito e com figuras (medicação, curativo, sinais de alerta); receita explicada ao acompanhante; contrarreferência para a UBS e para a equipe que acompanha o TEA; retorno marcado antes da saída.

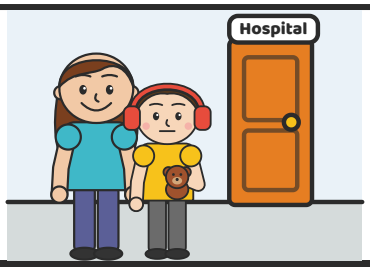
Encerre bem: elogio específico, adesivo ou certificado de "alta com coragem"; registre no prontuário o que funcionou, para a próxima internação.

Internação eletiva? Agende uma visita de ambientação dias antes: conhecer o quarto, a equipe e a rotina. Entregue a história social da página 7 com antecedência.

Eu no hospital

Para a família ler com a pessoa, na admissão e todos os dias da internação.

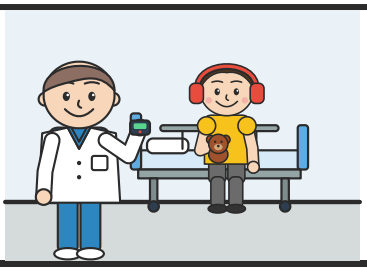
Recorte e entregue



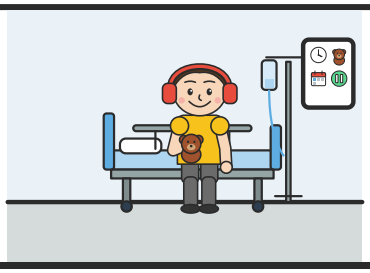
1 Hoje eu vou ao hospital. Chego com quem cuida de mim e levo meu brinquedo e meus fones.



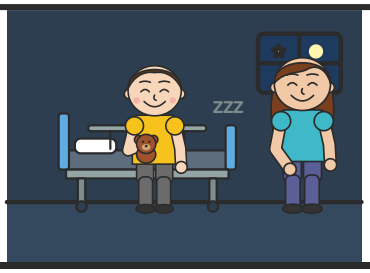
2 Uma enfermeira pergunta meu nome e mostra as carinhas: eu aponto se dói pouco, médio ou muito. Depois espero em um lugar calmo.



3 O médico me examina: o dedinho de luz, o "ouvidor" frio no peito, a braçadeira que aperta como um abraço. Ele avisa antes de cada coisa.



4 Eu fico em um quarto com uma cama que sobe e desce. Na parede tem o meu quadro do dia: remédio, lanche, brincar, visita, dormir.



5 Às vezes um aparelho faz "bip". Posso usar os fones. À noite a luz fica baixinha e quem cuida de mim dorme do meu lado.



6 Quando eu melhoro, ganho alta. Recebo um adesivo, digo tchau e vou para casa. Se eu precisar parar, levanto a mão.



Mão levantada

PARE. A equipe para e explica.



Pausa

Quero descansar um pouco.



Polegar

Tudo bem, pode continuar.

Para quem acompanha

- Entregue à equipe o "passaporte" do TEA: como ele se comunica, o que acalma, o que piora, o que já funcionou.
- Traga de casa: objeto de conforto, travesseiro, fones, tablet, alimentos que ele aceita (se liberados).
- Peça para estar junto nos exames, na indução anestésica e na recuperação, sempre que for permitido.
- Monte com a enfermagem o quadro do dia e avise-o de cada mudança antes que aconteça.
- Nos procedimentos, fique de frente para ele, com voz calma. Uma voz só de cada vez.
- Comemore cada passo e peça as orientações de alta por escrito e com figuras.

Hospital: _____ Quarto/leito: _____ Enfermeira(o) de referência: _____

História social ilustrada · Autoria: Dr. Patrício Almeida · Pode ser reproduzida gratuitamente para fins educativos.

Informativo e ficha

O TEA no hospital, em poucas palavras

O autismo é um espectro: cada pessoa é única. Sensorial (alarmes, luz, cheiros e toques sentidos de forma intensa), comunicação (entendimento literal; pode não falar, mas entende; a dor pode aparecer só como mudança de comportamento), previsibilidade (a quebra da rotina é o maior gatilho; mesma equipe, mesma sequência, quadro visual) e interesses intensos (aliados para explicar e recompensar). Direito a prioridade e a acompanhante em tempo integral.

Avaliar a dor: escala de faces (apontar) e observação



0 sem dor | 2 dói pouco | 4 um pouco mais | 6 dói bastante | 8 dói muito | 10 a pior dor

Sem fala: observe rosto, pernas, atividade, choro e consolabilidade (FLACC) e pergunte ao acompanhante o que é diferente do habitual.

O que dizer e o que evitar

Evite	Prefira
"Não vai doer nada, é rapidinho."	"Vai apertar e depois arder um pouco. Conto até dez."
Vários profissionais ao redor, falando ao mesmo tempo.	Uma pessoa de referência fala com ele; os outros falam com o acompanhante.
Segurar à força ou sedar "para acabar logo".	Reduzir estímulos, acompanhante, distração, pausa; contenção/sedação só por indicação e protocolo.
Trocar de leito, de equipe ou de horário sem avisar.	Avisar antes, atualizar o quadro do dia, apresentar quem chega pelo nome.
"Ele está agitado por causa do autismo."	Investigar dor, infecção, constipação, medo; perguntar "o que é diferente do habitual?".

Ficha rápida do perfil sensorial (anexar ao prontuário e passar no plantão)

Nome: _____ Idade: _____ Acompanhante: _____ Tel.: _____

Comunicação: ☐ Fala ☐ Figuras ☐ Gestos Como diz "sim/não/dor": _____

Incomoda: ☐ Alarmes ☐ Luz ☐ Cheiros ☐ Toque ☐ Garrote ☐ Deitar ☐ Pessoas novas

Acalma: _____ Alimentos aceitos: _____ Sono: _____

Funcionou: ☐ Fones ☐ Óculos ☐ Colo ☐ Contagem ☐ Quadro do dia ☐ Tablet PARE: _____

Medidas prescritas (luz, horários, acompanhante): _____

Base das recomendações: Falar–Mostrar–Fazer, dessensibilização, histórias sociais, apoio visual e reforço positivo; escalas de dor (faces, FLACC); Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com TEA (Ministério da Saúde); Política Nacional de Humanização. Autoria: Dr. Patrício Almeida. Material educativo; não substitui protocolos institucionais nem a avaliação clínica individual.